



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ від _____

**Керівникам структурних підрозділів
з питань охорони здоров'я
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та обласних
державних адміністрацій**

**Керівникам центрів контролю та
профілактики хвороб Міністерства
охорони здоров'я України**

**Національна служба здоров'я
України**

Щодо результатів посиленого
епідеміологічного нагляду за
протимікробною резистентністю

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) висловлює свою повагу і звертається з наступним.

На виконання положень Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 лютого 2023 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2023 року за № 489/39545 (далі – Порядок), заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (далі – стаціонари) проводять бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з ран, а також крові та ліквору від пацієнтів, які отримали поранення, у випадках що передбачені положеннями



№ 04-09/18/4495/23 від 14.08.2023
КЕП МАЦЬКОВ ОЛЕКСАНДР
ГРИГОРОВИЧ
248197DDFAB977E5040000001430801714B2C04

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-09/18/4495/23 від 14.08.2023



№22-3140/01-11/1-23 від 14.08.2023

Порядку. За результатами проведених досліджень бактеріологічні лабораторії щокварталу надають звіти до Центру за визначеною формою.

На запит Центру структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій сформували списки стаціонарів. Від 22 областей України було отримано перелік з 505 стаціонарів. Окремі стаціонари поза списками подали свої дані до Центру. За II квартал 2023 року надійшли звіти від 276 стаціонарів, що становить 50,5%.

За результатами проведеного аналізу отриманих звітів зроблені наступні **висновки**:

1) серед зразків біологічних матеріалів, що відбирались від пацієнтів, поранених внаслідок бойових дій, переважали зразки з ран – 93,8%. Вкрай низька кількість зразків крові (376), серед яких частка позитивних складає лише 25%, не дозволяє провести якісний аналіз отриманих даних та свідчить про недостатню обізнаність лікарів щодо показань для відбору зразків біологічного матеріалу;

2) найбільше штамів мікроорганізмів було виділено при відборі зразків біологічного матеріалу, коли від моменту поранення пройшло більше 72 годин, як при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин, так і менше 48 годин, що може бути пов'язано із перебуванням на попередніх етапах евакуації;

3) встановлений високий рівень стійкості негативних за Грамом мікроорганізмів до антимікробних препаратів у групі пацієнтів, що перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин, що вказує на внутрішньолікарняне інфікування;

4) переважна більшість мікробіологічних лабораторій стаціонарів не дотримуються методології EUCAST та не використовуються електронний інструмент WHONET, що передбачено положеннями Порядку;

5) для лікування пацієнтів, які отримали поранення, найчастіше призначались цефтриаксон та левофлаксацин. В той же час високий рівень стійкості ентеробактерій (*K. pneumoniae*, *E. coli*) до цефтриаксону, робить недоцільним його застосування з метою профілактики та емпіричної терапії інфекційних ускладнень при пораненнях. Початок лікування / профілактика антибіотиками широкого спектру дії на перших етапах евакуації, а також лікування без своєчасного проведення мікробіологічного дослідження і перегляду призначень в стаціонарах на різних етапах евакуації (при поступленні в кожен наступний стаціонар) призводить до пришвидшеної селекції антимікробної резистентності до цих антибактеріальних препаратів (далі – АБП);

6) виявлено стійкість до колістину у групі пацієнтів, які перебували в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин: *P. aeruginosa* – 35%, *Acinetobacter* spp. – 14%, *K. pneumoniae* – 24%, *E. coli* – 20%. До цих даних необхідно ставитись із обережністю через невелику кількість протестованих штамів;

7) позитивні за Грамом мікроорганізми зберігають високий рівень чутливості до усіх груп антибіотиків. Рівень MRSA коливається від 15% до 24%;

8) нераціональне / надлишкове використання меропенему-ваборбактаму (АБП не має реєстраційного посвідчення в Україні і є одним з найновіших АБП) призведе до поширення резистентності ще до офіційного поступлення на фармацевтичний ринок України. Це потребує раціоналізації його використання у стаціонарах (призначення виключно після отримання бактеріологічного підтвердження ефективності).

Зазначені вище висновки свідчать про невиконання вимог Порядку та недотримання галузевих стандартів у сфері медичної допомоги, вимагають відповідного реагування задля зниження поширення збудників з резистентністю та раціоналізації використання антибіотиків.

Рекомендації щодо зниження поширення збудників з резистентністю та раціоналізації використання АБП в стаціонарах включають:

1) забезпечити в стаціонарах дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та нормативно-правових актів. Використання класифікації WHO AWaRe дозволяє оптимізувати адміністрування АБП на рівні окремого стаціонару і на загальнонаціональному рівні. Відповідно до WHO AWaRe, антимікробні препарати з групи доступу мають хорошу активність проти широкого спектру найпоширеніших інфекційних агентів і мають менший, ніж у інших груп, потенціал до формування резистентності. АБП групи резерву та спостереження, навпаки, мають важливе значення для лікування більш специфічних, загрозливих або ж резистентних збудників при більшому потенціалі до формування резистентності.

Виявлена ситуація вказує на наслідки недотримання принципів WHO AWaRe – значне поширення резистентності до антибіотиків групи спостереження (цефалоспорини II та новіших поколінь, фторхінолонів), та вимагає якнайшвидшого переходу до раціонального призначення АБП з урахуванням класифікації WHO AWaRe. В Україні діє галузевий стандарт медичної допомоги, який враховує рекомендації WHO AWaRe – Стандарт медичної допомоги «Профілактика інфекційних ускладнень бойових поранень антибактеріальними лікарськими засобами на догоспітальному етапі», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2023 року № 1004 (далі – Стандарт). Відповідно до Стандарту для більшості випадків бойових поранень емпірично призначається цефазолін, а у випадку порушення цілісності шлунково-кишкового тракту – додатково метронідазол. Обидва АБП належать до групи доступу;

2) забезпечити можливість якомога швидше обстежувати пацієнта та отримувати результати бактеріологічних дослідження для перегляду призначень АБП. Найбільша поширеність резистентності грам-негативних збудників виявлена у пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні більше 48 год. Відповідно, інфікування відбувається у стаціонарі (внутрішньолікарняне інфікування) і емпірична антибіотикотерапія (без встановлення збудника і його чутливості до АБП) буде неефективною та призведе до селекції ще більшої кількості резистентних штамів;

3) забезпечити дотримання методології EUCAST. Мікробіологічні лабораторії повинні дотримуватися методології EUCAST, згідно якої

враховується локалізація інфекційного процесу та природна резистентність бактерій до АБП, а тому оцінюється чутливість лише до доцільних в певному випадку АБП. Це дозволяє уникнути проведення непотрібного аналізу чутливості та оптимізувати витрати бюджетних коштів на дослідження. Результати досліджень, що проведені не у відповідності до методології EUCAST, вводять в оману лікарів та можуть призводити до призначення неефективних АБП;

4) обмежити використання цефалоспоринів III покоління і фторхінолонів. Враховуючи, що для лікування поранених дуже часто емпірично призначають цефалоспорины III покоління та фторхінолони (група спостереження – WHO AWaRe) всупереч Стандарту, а рівень поширеності антимікробної резистентності до цих АБП високий, їхнє застосування нераціональне і шкідливе для цієї цільової групи та потребує обмеження (окрім моксифлоксацину у випадках передбачених Стандартом);

5) раціоналізувати призначення АБП. Результати мікробіологічних досліджень вказують на виділення непатогенних (коменсальних) бактерій у близько 50% поранених. Згідно положень Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 2022 року № 823, за відсутності ознак інфікування лікування АБП не показане. Тому, при прийнятті рішення щодо потреби у антибіотикотерапії необхідно обов'язково враховувати наявність / відсутність позитивних результатів бактеріологічних досліджень і клінічний стан пацієнта (наприклад, наявність / відсутність ознак бактеріального запального процесу, наявність / відсутність ознак системної запальної відповіді, наявність / відсутність підвищеного рівня маркерів запального процесу);

6) посилити обізнаність щодо необхідності проведення бактеріологічного обстеження поранених. Надзвичайно великий розрив між кількістю досліджених зразків з ран та крові (93,8% та 5,2% відповідно) опосередковано свідчить про необізнаність лікарів щодо показань до відбору зразків крові. Це призводить до гіподіагностики септичних станів та прийняття хибних рішень щодо тактики антибіотикотерапії. В умовах високого поширення резистентності до антимікробних препаратів, необхідно забезпечити навчання та нагадування для лікарів щодо показань до відбору зразків біологічних матеріалів і техніки такого відбору;

7) забезпечити дотримання стандартних заходів захисту. Стандартні заходи захисту – група заходів з профілактики інфікування, яких повинні дотримуватися усі працівники закладів охорони здоров'я (незалежно від наявності або відсутності у пацієнта інфекційної патології та в будь-яких умовах проведення догляду за ними). Впровадження і дотримання стандартних заходів захисту передбачено Заходами та Засобами щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2021 року № 1777, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1110/35393.

Стандартні заходи захисту засновані на припущенні, що будь-який пацієнт є потенційно інфікованим та може створювати інфекційні ризики для працівників та інших пацієнтів. Саме тому у будь-який час проведення догляду будь-якому пацієнту необхідно дотримуватися правил і вимог мінімально щодо:

- 1) гігієни рук;
- 2) використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду;
- 3) використання халатів захисних від інфекційних агентів залежно від методів проведення догляду;
- 4) респіраторної гігієни і етикету кашлю, використання медичних / хірургічних масок залежно від методів проведення догляду;
- 5) використання захисних окулярів або щитків залежно від методів проведення догляду;
- 6) безпеки при виконанні ін'єкцій;
- 7) використання чистого і безпечного медичного обладнання та інструментарію для проведення догляду;
- 8) безпечного управління медичними відходами;
- 9) очищення та дезінфекція приміщень;
- 10) використання чистої і безпечної білизни.

Належне дотримання стандартних заходів захисту суттєво знижує ризики передавання інфекційних агентів в закладах охорони здоров'я (серед працівників, пацієнтів і відвідувачів), що, відповідно, зменшує поширення збудників з антимікробною резистентністю.

Додатки: Аналітична довідка на 24 арк. у 1 прим.

Заступник Генерального директора

Олександр МАЦЬКОВ